

Contents

Plano de Trabalho — Mestrado Profissional PPGQualiSaúde/UFRN	1
Dados do candidato	1
Seção 1 — Apresentação e contexto de trabalho	2
Seção 2 — O que você deseja melhorar?	2
Seção 3 — Como pretende medir a melhoria?	3
Indicadores	3
Método de coleta e análise	3
Seção 4 — Que intervenções pretende realizar?	4
Intervenção 1: Padronização do fluxo regulatório	4
Intervenção 2: Painel de monitoramento público	4
Intervenção 3: Feedback ao solicitante	4
Intervenção 4: Auditoria concorrente	4
Intervenção 5: Capacitação da equipe reguladora	5
Seção 5 — Produtos técnicos possíveis	5
Guia para apresentação oral (10 minutos)	5
Roteiro cronometrado	5
Regras da apresentação	6
Preparação para arguição (20 minutos)	7
Perguntas esperadas da banca	7
Sobre o método	7
Sobre a viabilidade	7
Sobre o alinhamento acadêmico	7
Checklist final	8

Plano de Trabalho — Mestrado Profissional PPGQualiSaúde/UFRN

Edital nº 02/2026 — Turma 2026.2

Dados do candidato

Campo	Preenchimento
Nome completo	Nadielle D’Arc Batista Dias
E-mail	[e-mail da candidata]
Título do projeto	Otimização da gestão de filas para Atenção Especializada: transparência, fluxo regulatório e redução do tempo de espera
Linha de pesquisa	(X) Melhoria da Qualidade
Projeto estruturante	(X) 6. Temáticas Diversas

Campo	Preenchimento
Preferência de orientador(a) 1	Prof. Zenewton André da Silva Gama
Preferência de orientador(a) 2	Profa. Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa

Seção 1 — Apresentação e contexto de trabalho

Atuo na gestão e coordenação do Departamento Integrado de Regulação e Auditoria, onde lido cotidianamente com o gargalo entre a demanda regulada e a oferta de consultas e exames especializados no SUS. Minha trajetória profissional é marcada pela busca de eficiência na alocação de recursos públicos, conciliando o cumprimento de protocolos de regulação (SISREG e complexidade reguladora) com a necessidade de garantir equidade e transparência no acesso.

Identifiquei na gestão da qualidade o arcabouço teórico-metodológico necessário para transformar a regulação — historicamente percebida como processo burocrático — em um sistema de melhoria contínua centrado no usuário. O Mestrado QualiSaúde oferece as ferramentas (ciclos PDSA, indicadores, desenho de intervenções multifacetadas) e o ambiente acadêmico para validar cientificamente as mudanças que pretendo implementar.

Seção 2 — O que você deseja melhorar?

O tempo de espera para consultas e exames na Atenção Especializada é um dos principais indicadores de insatisfação do usuário e de ineficiência sistêmica no SUS. A Política Nacional de Regulação (PNR) e a Portaria de Consolidação nº 3/2017 instituem a regulação do acesso como função essencial do gestor, mas sua implementação permanece fragmentada.

Problema central: filas opacas — sem critérios públicos de priorização, sem feedback ao solicitante e sem monitoramento de tempos máximos — geram três consequências graves:

1. **Desigualdade de acesso:** pacientes com mesmo perfil clínico têm tempos de espera radicalmente diferentes a depender da unidade solicitante.
2. **Agravamento clínico:** condições que poderiam ser tratadas precocemente evoluem para estágios mais graves, aumentando o custo e reduzindo a chance de sucesso terapêutico.
3. **Desperdício de recursos:** consultas agendadas e não realizadas (absenteísmo), exames duplicados e encaminhamentos sem critério clínico claro.

Referencial teórico: O modelo de Donabedian (estrutura-processo-resultado) fundamenta a análise, e o ciclo PDSA (Plan-Do-Study-Act) orienta as intervenções. Autores como Vecina Neto e Malik (2018), Paim (2019) e a literatura do Institute for Healthcare Improvement (IHI) sobre *redução de filas em sistemas públicos* dão suporte à abordagem.

Oportunidade de melhoria: Redesenhar o fluxo regulatório local, transformando a fila de espera em um sistema rastreável, com critérios clínicos transparentes de priorização, prazos máximos por complexidade e devolutiva ao solicitante. A melhoria é oportuna no contexto da regulação municipal/estadual, onde convivem sistemas informatizados subutilizados, lógicas de agendamento manuais e ausência de indicadores de desempenho regulatório.

Seção 3 — Como pretende medir a melhoria?

Indicadores

Indicador	Definição operacional	Fonte	Periodicidade
Tempo médio de espera (dias)	Período entre a inserção no SISREG e o agendamento da consulta/exame	SISREG	Mensal
Taxa de efetividade do agendamento	(Consultas realizadas / Consultas agendadas) x 100	SIA/SUS	Mensal
Percentual de filas com priorização ativa	(Especialidades com classificação de risco documentada / Total de especialidades reguladas) x 100	Auditoria interna	Trimestral
Índice de transparência	Proporção de solicitantes que declaram ter recebido posição na fila	Questionário estruturado	Semestral
Taxa de absenteísmo	(Pacientes que não compareceram / Total agendado) x 100	SISREG	Mensal

Método de coleta e análise

Os dados secundários serão extraídos diretamente do SISREG e do SIA/SUS. Os dados primários (transparência) serão coletados por questionário aplicado a uma amostra de médicos solicitantes.

A análise seguirá desenho de série temporal interrompida (ITS), comparando os 6 meses pré-intervenção com os 12 meses pós-intervenção. Serão utilizados: - **Run charts** com medianas e limites de controle para cada indicador - **Teste t pareado** ou **Wilcoxon** para comparar médias pré/pós (previa verificação de normalidade por Shapiro-Wilk) - **Análise descritiva** estratificada por especialidade e complexidade

Os resultados serão apresentados trimestralmente em reuniões de pactuação com a equipe reguladora e a gestão.

Seção 4 — Que intervenções pretende realizar?

Intervenção 1: Padronização do fluxo regulatório

O quê	Elaboração de protocolo escrito de classificação de risco por especialidade, com critérios explícitos e gatilhos de prioridade
Como	Revisão da literatura + oficinas com especialistas reguladores + aprovação em CIB local
Quem	Coordenação do Departamento + equipe reguladora + apoio da gestão
Quando	Meses 1-3
Risco	Resistência de especialidades à padronização → mitigado por construção participativa

Intervenção 2: Painel de monitoramento público

O quê	Dashboard com status da fila por especialidade, tempo médio e vagas ofertadas
Como	Ferramenta de Business Intelligence (Power BI ou Metabase) alimentada pelo SISREG
Quem	Departamento de TI + coordenação
Quando	Meses 2-4
Risco	Disponibilidade técnica da TI → escopo reduzido viável (planilha dinâmica como MVP)

Intervenção 3: Feedback ao solicitante

O quê	Notificação automática sobre posição do paciente na fila e prazo estimado
Como	Integração SISREG × plataforma de mensageria (WhatsApp Business API ou e-mail institucional)
Quem	Departamento de TI + coordenação
Quando	Meses 4-6
Risco	Custo de implantação → solução escalonável: iniciar com e-mail, evoluir para SMS/WhatsApp

Intervenção 4: Auditoria concorrente

O quê	Revisão semanal de amostra aleatória de solicitações para verificar conformidade com o protocolo
Como	Técnico da regulação designado + checklist padronizado
Quem	Equipe de auditoria interna
Quando	Meses 3-12
Risco	Sobrecarga da equipe → amostra de 10% das solicitações, rotativa por especialidade

Intervenção 5: Capacitação da equipe reguladora

- 4 oficinas presenciais (uma por trimestre) sobre ferramentas da qualidade: PDSA, fluxograma, diagrama de causa e efeito, carta de controle.
- Conteúdo alinhado às disciplinas do Mestrado, criando ponte teoria-prática.
- Público-alvo: reguladores, auditores, apoiadores administrativos.

Seção 5 — Produtos técnicos possíveis

Tipo de PTT (CAPES/Saúde Coletiva)	Produto proposto	Aderência ao projeto
Manual / Protocolo	Protocolo municipal de regulação ambulatorial por especialidade	Intervenção 1
Tecnologia social / Processo	Painel de transparência de filas para Atenção Especializada	Intervenção 2
Fluxograma / Procedimento técnico	Fluxo regulatório padronizado com tempos máximos e gatilhos de prioridade	Intervenções 1 e 4
Relatório técnico conclusivo	Análise de impacto da intervenção multimodal sobre o tempo de espera	Todas as intervenções
Base de dados / Dataset	Série histórica anonimizada de indicadores regulatórios (pré e pós)	Todas as intervenções
Curso de curta duração	“Gestão de filas no SUS: ferramentas da qualidade para regulação”	Intervenção 5

Guia para apresentação oral (10 minutos)

Roteiro cronometrado

Minuto	Conteúdo	Dica
0'00–1'00	Abertura: quem sou, onde trabalho, qual o problema central das filas na AE	Contexto profissional + problema em 3 frases
1'00–2'30	Oportunidade de melhoria: as 3 consequências das filas opacas (desigualdade, agravamento, desperdício) + referencial Donabedian/PDSA	Cite 1 dado concreto do seu serviço
2'30–4'00	Indicadores: mostre os 5 indicadores (tabela mental), destaque tempo médio de espera como primário	“O que não se mede não se gerencia”
4'00–6'00	Intervenções: apresente o combo multimodal — protocolo, painel, feedback, auditoria, capacitação	Use a lógica “padronizar → monitorar → comunicar → verificar → sustentar”
6'00–7'00	Viabilidade: escopo de 12 meses, equipe existente, ferramentas disponíveis, baixo custo incremental	Mostre que é factível, não ambicioso demais
7'00–8'00	Produtos técnicos: destaque o protocolo e o painel como PTTs principais	Alinhe com o que a CAPES valoriza
8'00–9'00	Impacto esperado: redução do tempo de espera, aumento da transparência, modelo replicável	“Este projeto pode ser piloto para outros municípios”
9'00–10'00	Encerramento: síntese dos 3 pilares (medir + intervir + sustentar) + alinhamento com o QualiSaúde	Termine com frase de impacto

Regras da apresentação

- **Sem recurso audiovisual** (edital, item 61) — apenas sua fala.
- **Máximo 10 minutos** — cronometre nos ensaios. A banca pode interromper se estourar.
- **Tom técnico, não político** — foque em metodologia e evidência, não em crítica à gestão.
- **Esteja preparado para ser interrompido** — a banca pode pedir esclarecimentos durante a apresentação.

Preparação para arguição (20 minutos)

Perguntas esperadas da banca

Sobre o método

Pergunta	Resposta esperada
Por que série temporal interrompida e não um ensaio controlado?	Porque a intervenção é no nível do serviço, não individual. ITS é o padrão-ouro para estudos de melhoria da qualidade (JBI, SQUIRE 2.0). Não há grupo controle viável na regulação.
Como vai garantir que a melhoria observada não é devida a fatores externos?	Documentação de cointervenções (mudanças na gestão, novas portarias) e análise de sensibilidade excluindo períodos atípicos.
Qual o tamanho da amostra para o questionário de transparência?	Amostra de conveniência com todos os médicos solicitantes de 3 especialidades piloto (estimativa: 30-50 respondentes). Suficiente para estatística descritiva.

Sobre a viabilidade

Pergunta	Resposta esperada
O SISREG permite a extração de dados que você precisa?	Sim, o SISREG possui módulo de relatórios. Em caso de limitação técnica, a ouvidoria municipal obriga a alimentação de dados de fila por lei.
Como lidar com a resistência dos médicos reguladores?	Engajamento precoce nas oficinas, mostrando que o protocolo reduz carga de decisão individual e padroniza critérios — proteção jurídica para o regulador.
Qual o custo estimado do painel?	Ferramentas gratuitas (Metabase ou Google Looker Studio) + horas de TI já alocadas. Custo marginal próximo de zero.

Sobre o alinhamento acadêmico

Pergunta	Resposta esperada
Como este projeto se insere na linha Melhoria da Qualidade?	Porque atua sobre processo (fluxo regulatório), utiliza métodos da qualidade (PDSA, indicadores) e gera produtos técnicos reconhecidos pela CAPES.
Qual a diferença entre seu projeto e o projeto “Temáticas Diversas”?	Temáticas Diversas acolhe propostas transversais que não se encaixam nos projetos 1-5. Meu projeto poderia futuramente dialogar com os projetos Qualidade na APS (fronteira entre APS e AE) ou Segurança no Macrossistema (governança regulatória).

Pergunta	Resposta esperada
Que disciplina do programa é mais relevante para seu projeto?	Qualidade em Serviços de Saúde (fundamentação) + Métodos e Técnicas de Pesquisa (desenho) + Sistemas de Informação em Saúde (extração de dados).

Checklist final

- ☐ Inscrição no SIGAA dentro do prazo (17/03 a 17/04/2026)
- ☐ Isenção de taxa, se aplicável (até 27/03/2026)
- ☐ Documentação anexada: diploma, currículo Lattes, plano de trabalho e demais itens do art. 28
- ☐ Plano de Trabalho preenchido no Google Forms: <https://forms.gle/GyNgQjkPLyonXVAC7>
- ☐ Cópia em PDF do Plano salva e anexada à inscrição
- ☐ Ensaaios da apresentação oral cronometrados (mínimo 3 ensaios)
- ☐ Leitura da banca: conheça o perfil dos professores que avaliarão
- ☐ Preparação de respostas para perguntas acima (mínimo 2 rodadas de simulação)

Documento gerado em 04/06/2026 com base no Edital nº 02/2026 do PPGQualiSaúde/UFRN.